EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88526
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-07-13 17:52:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JORGE RAUL MOLINA BASCUR			RUN	: 5.103.801-0
F.Nac	: 02-11-1927	Edad	: 96 AÑOS, 8 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-07-12	Fecha Egreso	: 2024-07-13 17:52:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico, obs parietal derecho 2° a estenosis ACI bulbar
-Ant: HTA - ICC - LCFA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

BEG, HDN estable, RS al monitor, eupneico, afebril, tolera bien alimentación VO consistencia papilla, estable en déficit neurológico evaluado ayer en la tarde (hemiparesia BC izquierda M4), no refiere molestias, sin recurrencias.
TC cerebro s/c de ingreso no evidencia lesiones agudas.
AngioTC cerebro y cuello muestra estenosis origen ACI cervical derecha de >70%, ACI cervical izquierda 30% y aprox origen arteria subclavia izquierda de 60% (con placa ulcerada). En fase parénquima no observo lesiones agudas por mala definición imagenológica.
TC tórax s/c no muestra signos de condensación pulmonar.
Exs de lab de sin hallazgos significativos.
Inicio DAPT con carga de clopidogrel.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy, IC HODOM (para rehabilitación kinésica y fonoaudiológica) y control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-15 días con ETT, Holter de ritmo y TC cerebro s/c de control.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-DAPT por al menos 3 meses
-IC HODOM (para rehabilitación kinésica y fonoaudiológica
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-15 días con ETT, Holter de ritmo y TC cerebro s/c
-Reiniciar tto crónico usual

INDICACIONES AL ALTA

1. -Aspirina 100 mg/día
2. -Clopidogrel 300 mg hoy, 75 mg/d desde el domingo
3. -Famotidina 40 mg/día
4. -Atorvastatina 40 mg 2 comp/noche

EXÁMENES Y RESULTADOS

13/7/24
-TSH 0.67 T4L 0.83
-B12 397
-RPR N/R
-Hb glic pendiente

12/7/24
-Crea 0.6 MDRD 124.93 Uremia 31
-AU 3
-Ca 9
-FA 63 BI 0.54 BD 0.16 BT 0.7 GOT 23 GPT 14 GGT 22
-CKMB 8 CK 45
-ColT 107 TG 59
-Lact 1.6
-PCR 6.9
-Na 137 K 3.6 Cl 103
-Hb 15.1 Leu 8000 Seg 198000 Seg 68
-INR 1.08 TTPA 29
-Trop 15.7

OBSERVACIONES:

Ex fco gral:
-Perfusión e hidratación N, yug no ingurgitadas, rash vesicular eritematosis subcostal derecho
-Cardiaco: RR 2T no ausculto soplos
-Pulmonar: MP(+) roncus y estertores escasos bilaterales
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico:
-Mental: vigil, atención N, OTE, lenguaje N
-PC: CV por amenaza impresiona N, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC izquierda leve, nistagmo(-), disartria leve, fuerza ECM M5 bilateral, úvula y lengua centrales, fuerza trapecio der M5 e izquierdo M4
-Motor: fuerza BC der M5 y BC izquierda M4 proximal y M3-M4(-) distal, RCP extensor izquierdo
-Sensibilidad: conservada
-Cerebelo: conservada (proporcional a paresia)
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO